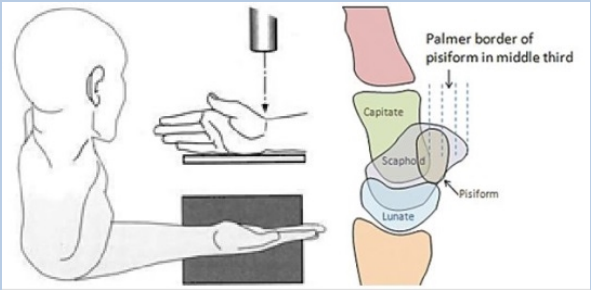
RG Håndledd

Endring siden forrige versjon
Revidert. Presisert at "knytebilde" skal tas uten gips.

Indikasjon	Smerte, skade, kontroll, håndrotskade utenom scaphoid	*Front AP, Side, Side med skråpute* ***Tilleggprosjeksjoner skade:*** *Eventuelle skråbilder (se kommentar på **Side**)* ***Tilleggprosjeksjoner smerte/skade:*** *Frontbilder med provokasjon* *Sidebilder med provokasjon*
	Scaphoid-lunatum-dissosiasjon	*«Knytebilde»*

FRONT PA		
INFORMASJON		
POSISJONERING	Armen i PA på detektor. Armen løftet med 90° i skulderledd og 90° i albue.	
SENTRERING	I håndleddets midtlinje, midt på håndrøttene, omtrent 1cm distalt for processus styloideus ulna	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Radius og ulna fremstilles uten rotasjon, samt uten overprojisering av hverandre. Hånden uten deviasjon. Inkluder 1/3 av underarm, nesten hele metacarpene og tommelens grunnledd.	
KOMMENTAR	Ved 90° i skulder og albue unngår man rotasjon av radius og ulna, og de visualiseres i sann lengde, og man unngår skråstilling av håndleddet.	
SIDE		
INFORMASJON		
POSISJONERING	Bord/arm senkes ned med armen inntil kroppen. Håndleddets ulnarside skal ligge mot detektor.	
SENTRERING	I radius' midtlinje, midt på håndrøttene, omtrent 1cm distalt for processus styloideus radii.	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Radius og ulna overprojiseres, med 2. til 5 metacarp på linje og overprojisert av hverandre. Hånden uten ventral eller dorsal fleksjon. Det skal være en rett linje gjennom radius, lunatum, capitatum og 3.metacarp. Helt distalt	

	skal radius visualiseres uten å overprojisere ulna dorsalt. Inkluder 1/3 av underarm og nesten hele metacarpene.	
KOMMENTAR	Ved spørsmål om skade kan det være aktuelt med tilleggsprojeksjoner. Med utgangspunkt i rett side, supineres eller proneres håndleddet med omtrent 20° eller mer avhengig av hva som ønskes visualisert.	
SIDE MED SKRÅPUTE		Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON		
POSISJONERING	Med ulnarsiden vendt mot detektor og albuen på underlaget, heves distale underarm opp fra detektor med en skråpute, nært opptil 23˚, med omtrent 90˚ i albuen. Antall grader kan variere fra person til person.	
SENTRERING	I radius' midtlinje, midt på håndrøttene, omtrent 1cm distalt for processus styloideus radii.	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Radius og ulna overprojiseres, med 2. til 5 metacarp på linje og overprojisert av hverandre. Hånden uten ventral eller dorsal fleksjon. Helt distal skal radius visualiseres uten å overprojisere ulna dorsalt. Den radiale leddflaten fremstilles åpen. Inkluder 1/3 av underarm og nesten hele metacarpene.	
KOMMENTAR		
FRONTBILDE MED PROVOKASJON	Røntgenbilde settes inn her	Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	**2 bilder tas**. Ett med betydelig ulnardeviasjon, og ett med betydelig radialdeviasjon. **Kun på forespørsel.**	
POSISJONERING	Hardt knyttet hånd, samt armen i PA på detektor. Armen løftet med 90° i skulderledd og 90° i albue. Ett bilde tas med betydelig ulnardeviasjon, og ett med betydelig radialdeviasjon	
SENTRERING	I håndleddets midtlinje, midt på håndrøttene, omtrent 1cm distalt for processus styloideus ulna	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Radius og ulna fremstilles uten rotasjon, samt uten overprojisering av hverandre. Ett bilde viser tydelig ulnardeviasjon, og ett viser tydelig radialdeviasjon. Inkluder 1/3 av underarm, nesten hele metacarpene og tommelens grunnledd.	
KOMMENTAR		
SIDEBILDE MED PROVOKASJON	Røntgenbilde settes inn her	Illustrasjon settes inn her
INFORMASJON	**2 bilder tas.** Ett bilde med betydelig fleksjon og ett med betydelig ekstensjon. **Kun på forespørsel.**	
POSISJONERING	Bord/arm senkes ned med armen inntil kroppen. Håndleddets ulnarside skal ligge mot detektor. Ett bilde tas med fleksjon i håndleddet, og ett med ekstensjon.	

SENTRERING	I radius' midtlinje, midt på håndrøttene, omtrent 1cm distalt for processus styloideus radii.	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Radius og ulna overprojiseres, med 2. til 5 metacarp på linje og overprojisert av hverandre. Ett bilde med hånden ekstendert maksimalt og ett med hånden flektert maksimalt. Inkluder 1/3 av underarm og nesten hele metacarpene. Merk bildene med hva slas provokasjon som er gjort.	
KOMMENTAR		
«KNYTEBILDE»		
INFORMASJON	Tas ved spørsmål om økt avstand mellom scaphoideum og lunatum (SL-dissosiasjon)	
POSISJONERING	Begge håndleddene plasseres **uten gips** pronert i rett PA på detektoren og pasienten lager knyttnever. Sentrer på håndleddene og eksponer mens pasienten holder hendene **hardt knyttet** (gjerne rundt en blyant el.) Begge tas på ett bilde.	
SENTRERING	Midt på håndrøttene, omtrent 1cm distalt for processus styloideus ulna, midt mellom håndleddene	
STRÅLERETNING	0˚	
BILDEKRITERIER	Radius og ulna fremstilles uten rotasjon, samt uten overprojisering av hverandre. Rett PA visualiseres også ved friprojisering av SL-ledd. Inkluder basale deler av metacarper, samt distale radius og ulna. Merk bilde med «høyre/venstre», samt «knytebilde».	
KOMMENTAR	Bildet tas uten gips. Det kan være enklere å få til rett PA med detektoren hevet opp slik at pasienten sitter med 90° i skulderleddet	

Referanser

Vedlegg

Slutt på Prosedyre